

吸收不良综合征 30 例临床分析

钟欣¹,袁平宗²,吴亚敏²(1. 内江医科学校,四川 内江 641100;2. 内江市第二人民医院,四川 内江 641100)

【关键词】 吸收不良综合征; 消化不良; 诊断; 治疗

doi:10.3969/j.issn.1009-5519.2013.13.089

文献标识码: B

文章编号: 1009-5519(2013)13-2076-02

吸收不良综合征是指多种营养成分和矿物质未被正常吸收所引起的临床综合征。广义的吸收不良综合征包括消化不良与吸收不良,故又称为“消化吸收不良综合征”。许多疾病均可引起本综合征,但其临床表现及实验室检查结果往往相似。吸收不良综合征患者对脂类几乎总是不能正常地吸收,有时也可选择性地对某种单一营养成分吸收障碍^[1-3]。现就本院 2011 年 2 月至 2013 年 2 月资料较完整的 30 例吸收不良综合征患者的临床症状、实验室诊断作一回顾性分析。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 30 例患者中男 22 例,女 8 例;年龄 21~65 岁;病程 2 个月至 15 年。

1.2 诊断标准^[4] (1)有慢性腹泻、体质量减轻、贫血、维生素或矿物质缺乏等表现;(2)有脂肪吸收不良和(或)D-木糖吸收试验显著异常;(3)临床诊断经小肠活检、胃肠 X 射线钡剂检查、胰功能检查,少数经病理或治疗反应证实。

2 结果

2.1 临床表现 大便 3~8 次/天 26 例,10~20 次/天 2 例,2 次/天 2 例;性状多为浅黄色或白色稀水样(22 例)或糊状(8 例),量多;9 例有恶臭,3 例见油滴,2 例软便。19 例伴不同程度腹胀、腹痛;体质量下降 28 例,其中 13 例下降 5~20 kg,10 例下降 30 kg,最多达 50 kg,5 例呈恶病质;贫血貌 14 例,其中轻度贫血 6 例,中度贫血 7 例,重度贫血 1 例(血红蛋白仅 57 g/L);贫血中 7 例有三系细胞减低;1 例胃大部切除行骨髓涂片检查提示为巨幼细胞性贫血;血清铁低 1 例,水肿 10 例,舌炎 5 例,口角炎 2 例,毛囊角化 8 例,手足搐搦 4 例。

2.2 脂肪吸收试验 30 例中做 ¹³C-Hiolein 呼气试验 6 例,脂肪吸收试验结果阳性见表 1。

表 1 脂肪吸收试验阳性结果[n(%)]

试验项目	n	阳性[n(%)]
粪苏丹Ⅲ染色(+)	30	18(60.00)
24 h 粪脂测定大于 6 g	30	28(96.33)
苏丹Ⅲ(+)/粪脂(+)	30	18(60.00)
苏丹Ⅲ(-)/粪脂(+)	30	10(33.33)
¹³ C-Hiolein 呼气试验	6	6(100.00)

2.3 胰腺功能试验

2.3.1 N-苯甲酰-L 酪氨酰对氨基苯甲酸(BT-PABA)试验 尿 PABA 低于正常 20 例,其中胰腺癌 2 例,肠源性疾病 17 例,原因不明 1 例。尿 PABA 及 D-木糖醇均低者 10 例,另 3 例尿 PABA 低而 D-木糖醇正常者中,胰腺癌 2 例,克罗恩(Crohn)病多发内瘘 1 例。

2.3.2 胰泌素试验 2 例胰腺癌重碳酸盐含量均减少,其中 1 例

胰液总量减少。

2.4 X 射线检查 包括全胃肠影像、气钡对比小肠注钡造影或钡灌肠等检查,结果提示,吸收不良或可能病因者 19 例[79.2%(19/24)]。典型小肠吸收不良所见如小肠黏膜增粗、钡影分节、雪片状改变或局部肠腔扩张、钡影稀释等共 6 例。病因提示免疫缺陷病 2 例,升结肠癌、Crohn 病多发内瘘、肠结核并不全梗阻、短肠、多发憩室并内瘘、可疑小肠淋巴瘤各 1 例,胃大部切除术后 5 例。

2.5 随访 死亡 8 例,其中胰腺癌、小肠淋巴瘤各 2 例,卵巢癌术后并发放射性肠炎 1 例,结肠癌、胰岛细胞瘤各 1 例、短肠(自杀)1 例。失访 2 例。余 20 例(胃大部切除术后 5 例,成人乳糜泻 4 例、肠结核 2 例、获得性低 γ 球蛋白血症 2 例、回肠远端吻合术后 1 例、Crohn 病多发内瘘 1 例、空肠憩室伴出血 1 例、全身粟粒性结核 1 例、蓝氏贾第鞭毛虫感染 1 例、嗜酸性肠炎 1 例、脆弱双核阿米巴感染 1 例)经治疗原发病及补充营养后均存活,且病情有不同程度好转,4 例乳糜泻用无麸质饮食后均恢复。

3 讨论

胃肠道消化和吸收的生理过程十分复杂,多种疾病均可影响消化和吸收过程的 3 个时期(腔内期、黏膜期和运送期)中某个或几个环节,从而影响营养物质的吸收。按消化和吸收的病理生理变化,根据吸收不良综合征病因分类的特征,本文通过对 30 例患者进行吸收不良综合征的筛检、吸收不良检测、消化不良检验 3 个步骤的实验室诊断,除 2 例病因未明外,其余 28 例分属 17 种疾病,12 例以腔内原因为主,包括胰腺癌、多发性内分泌腺瘤属胰酶缺乏、胃大部切除术后、回肠远端切除术后和内瘘等属肠道细菌过长或胆盐缺乏;其他 16 例属各种疾病所致黏膜异常。吸收不良的病因多样,但由于诊断手段有限,且临床医生往往在作出某一种疾病诊断后,再作进一步检查,进而在最后找出充分依据后才作出吸收不良综合征的诊断。所以,临床上应及时进行相关检查、明确病因,并针对病因进行治疗及营养补充,大多预后良好^[5-7]。

建议实验室诊断方法与步骤如下。(1)吸收不良综合征的筛检:①患者主要特点是腹泻、水样或糊状便,量多,有时恶臭,伴不同程度体质量下降,甚至恶病质。此时应怀疑存在吸收不良。②胃肠 X 射线钡剂检查可作为初筛,一般先做全胃肠造影,进一步做小肠气钡双对比造影,必要时做十二指肠低张造影或气钡双对比灌肠,以提高黏膜病变阳性发现率。但 X 射线钡剂检查不能完全确立或排除诊断^[8]。(2)吸收不良的检查(即小肠黏膜完整性试验):本组测尿 D-木糖吸收试验 15 例阳性,8 例属肠道病变较广泛,余不能除外小肠细菌过长。(3)消化不良的检查(胰腺功能试验):①BT-PABA 试验测定糜蛋白酶功能。本组 20(20/28)例低于 60%,除 2 例胰腺癌外,17 例为肠源性病变,1 例原因未明,说明影响 BT-PABA 试验的因素较多。小肠吸收不良尿 PABA 排出率亦降低,此时可做 D-木糖吸收试验。②胰泌素或促胰酶素-胰泌素试验^[9],

本组 2 例胰腺癌重碳酸盐排出量均减少。一般只有胰腺破坏到一定程度或胰管受阻时才出现异常。因此,以上胰功能试验均有其局限性,应结合逆行胰胆管造影、B 超或 CT 检查,甚至在 B 超或 CT 引导下行细针穿刺取病理或手术组织活检以明确诊断^[10]。

参考文献

- [1] 侯海群. 小肠吸收不良综合征的观察及护理体会[J]. 现代医药卫生, 2006, 22(8): 1220.
- [2] 邱运芬. 小肠吸收不良综合征护理[J]. 中国伤残医学, 2011, 19(10): 54.
- [3] 陈璐, 闫尚峰, 刘茜, 等. 健脾止泻汤治疗小肠吸收不良综合征 36 例观察[J]. 实用中医药杂志, 2010, 26(10): 678-679.
- [4] 沈志祥. 吸收不良综合征的病因分类[J]. 中国医刊, 1992, 27(6): 10.
- [5] 王红梅. 小肠吸收不良综合征患者的护理干预分析[J]. 中外医学研究, 2012, 10(36): 74-75.
- [6] 伍颖彬, 黄太基. 幽门螺旋杆菌感染与胃肠疾病的发病机制及治疗概况[J]. 湖南中医杂志, 2013, 29(3): 135-137.
- [7] 姜盈. 吸收不良综合征的临床治疗体会[J]. 中国现代药物应用, 2010, 4(24): 109.
- [8] 孙利民. 小肠吸收不良综合征的 X 线诊断[J]. 蛇志, 2008, 20(3): 226-227.
- [9] 辛桂霞, 丁金秀. 呼气试验在胃肠道疾病中的临床应用及价值[J]. 上海医药, 2009, 30(6): 259-260.
- [10] 麻树人. ERCP 发展历史回顾与应用现状[J]. 中华消化内镜杂志, 2009, 26(5): 225-227.

(收稿日期: 2013-03-30)

胫骨近端骨折髓内钉固定进针点选择探讨

李 进, 李贵振(恩施市中心医院骨科, 湖北 恩施 445000)

【关键词】 半月板, 胫骨; 骨折固定术, 髓内; 胫骨骨折; 进针

doi: 10.3969/j.issn.1009-5519.2013.13.090

文献标识码: B

文章编号: 1009-5519(2013)13-2077-02

交锁髓内钉治疗胫骨干骨折在临床上已成为“金标准”, 但医生对于胫骨近侧近端骨折在选择内固定器材上会陷入两难, 钢板切开复位简单, 但胫骨近端软组织少, 创伤容易使皮肤坏死而钢板外露, 选用髓内钉固定, 术后发生感染的概率低^[1], 但会出现术中复位困难, 控制不住骨折移位, 强行复位可造成医源性损伤、骨质劈裂, 术后骨折成角或内外翻畸形。有学者报道用髓内钉治疗胫骨近端骨折并发症发生率较高, 应避免使用髓内钉^[2]。现就本院 2000—2002 年收治的 10 例胫骨近端骨折患者采用髓内钉固定术治疗的体会报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组 10 例患者中, 男 7 例, 女 3 例; 年龄 22~56 岁。致伤原因: 车祸伤 4 例, 跌滑伤 3 例, 坠落伤 3 例, 均为闭合性骨折。骨折均位于近端, 依据骨折线短斜行骨折 7 例, 粉碎性骨折 3 例, 均为 10 d 内的新鲜骨折。全部患者术前骨折均有明显移位。

1.2 手术方法 患者取仰卧位, 常规硬膜外麻醉, 根据进钉需要选择髌旁入路或中线入路。在矢状面上, 钉道入口位于胫骨平台边缘。根据骨折类型选择外、内侧或正中入口。如果前后位 X 射线片提示骨折紧贴胫骨平台外侧, 进钉点应紧贴髌腱外侧(外侧髌旁切口); 如果骨折过于靠近内侧膝关节骨皮质, 则进钉点应紧贴髌侧内侧(内侧髌旁切口); 如果骨折线为罕见的胫骨平台下水平状, 则进钉点位于正中线(劈开髌腱切口)。如果骨折近端存在前向移位和(或)成角, 则置正中外侧防旋钉; 如果进钉后, 外翻/内翻畸形不能改善, 则需加装前后位“防移位”螺钉进行复位。峡部粉碎骨折并不会明显影响固定质量(除非进钉点旁有一侧骨皮质已全部粉碎或缺失)。髓内钉一定要置在胫骨近端中间或近中位上, 否则易引起对线不良。在参考上述细节的基础上进行闭合复位髓内钉固定术。

1.3 术后康复 术后应尽快恢复膝关节的被动和主动运动。非负重锻炼 4~6 周, 4~6 周后根据骨折粉碎程度以及患者愈合情况逐渐加强锻炼。根据愈合程度, 10~16 周可完全负重活动。

2 结 果

经上述原则治疗的患者, 术后复查胫骨正侧位 X 射线片, 绝大部分可以达到预期目标(成角畸形小于 5°, 移位小于 5 mm), 仅 1 例未能满足, 主要是术中未能发现需要复位的畸形, 因而没有考虑加装锁钉。此外, 有 1 例患者术前评估不良, 因此导致钉道选择错误, 最终复位效果不良(15°内翻)。

3 讨 论

合理的固定和良好的血液循环是骨折愈合的基本要素。Terjesen 等^[3]认为, 带锁髓内钉通过中轴线弹性固定可使骨折端均匀地承受压力, 提高抗折弯、抗旋转的能力, 避免剪、扭等有害应力, 最大限度地克服因偏心固定所产生的应力遮挡效应。由于带锁髓内钉的这种力学优势, 且手术最大限度地保持了骨膜的完整性和连续性及其软组织的血液循环, 为骨折愈合提供了一个良好的生物学环境^[4]。

胫骨髓内钉多用于胫骨中段骨折, 用于近端骨折并发症发生率较高, 多发生畸形愈合。究其原因是因为骨折手术复位不佳引起多种严重的术后并发症。有资料报道 84% 的患者发生畸形愈合, 1/2 的患者骨折端有 1 cm 移动, 1/4 固定失效, 临床医生很多时候是用支撑钢板来处理此类骨折。在应用髓内钉固定技术时, 不当的开口点会造成进针困难, 扩髓入口与进钉方向不一致, 强行插入髓内钉要么骨折断端移位, 要么骨质劈裂, 造成医源性骨折。为了获得满意的复位效果, 医生在术中往往会通过变换患者体位以及适当选取髌旁、髌后入路等改进技术提高复位效果。额状面进钉位置是胫骨近端骨折髓内钉手术复位的一项潜在影响因素, 进钉位置决定复位效果, 合理的髓内钉入路可以有效地辅助复位, 并简化手术操作和减少术后并发症。对于胫骨近侧近端骨折来说, 用髓内钉复位可以通过调整开口点来提高准确性, 骨折线近端靠近哪一侧, 进钉点就应适当偏向于哪一侧, 并注意近端髓内钉通道与远端通道的一致性, 这样可以有效地辅助复位, 改善患者术后功能的恢复。